

Entregable 3

Entendiendo al Usuario pt.2

Caso Clínico 8

Paciente Palomino





Casos de Referencia

CASO 1

Lesión C4-C5 por arma blanca. Muestra recuperación funcional favorable con rehabilitación. [1]

CASO 2

Lesión C5 AIS "D" crónica. Demuestra efectividad del entrenamiento intensivo bimanual y control postural para reeducar la marcha [2]

CASO 3

194 pacientes con lesión cervical. Confirma que la clasificación AIS "D" otorga una alta probabilidad de recuperar la marcha. [3]

[1] Y. C. H. Dokponou, M. El Mostarchid, H. Abderrahmane, N. P. Koffi, M. Gazzaz, and B. El Mostarchid, "Spontaneous recovery of penetrating cervical spinal cord injury with physiotherapeutic treatment: Case report and review of the literature," Case Reports in Neurological Medicine, vol. 2021, Art. no. 3741461, 2021. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2021/3741461>

[2] K. Jimbo, T. Murayama, K. Takahama, T. Yoshimura, T. Goto, T. Tosaka, K. Suzuki, M. Kitagou, and N. Kikuchi, "Effect of training combining hand-arm bimanual intensive therapy concept and postural control elements on individuals with chronic incomplete cervical spinal cord injury: A report of two cases," Cureus, vol. 17, no. 2, Art. no. e79695, Feb. 2025, doi: 10.7759/cureus.79695. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11952134/>

[3] V. Stenimahitis, M. Gharios, A. Fletcher-Sandersjö, et al., "Long-term outcomes and predictors of neurological recovery in cervical spinal cord injury: A population-based cohort study," Scientific Reports, vol. 14, p. 20945, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-71983-2. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71983-2>



Perfil funcional

- **Habilidades Conservadas:** Comunicación fluida, marcha con andador, independencia en la mayoría de AVD y adaptación.
- **Principales Limitaciones:** Limitación de rangos articulares en hombro derecho (flexión, abducción, rotaciones), con dolor leve a la palpación en inserción de bíceps y pectoral derecho.

Evaluaciones Clínicas

- 
- ISNCSCI/ASIA: C4 nivel de lesión, C5(D) / C6(I) nivel motor
 - Clasificación: AIS D (incompleta).
 - SCIM III: Vejiga = 11/15 e Intestino = 0/15
 - Ashworth: 2 - 3 (Tono incrementado en las 4 extremidades)
 - Penn: 1 (espasmos leves)

Mapa de Actividades Críticas

Parcialmente independiente en alimentación; dependiente de terceros para vestido e higiene en el INR.

ABVD



Sin empleo formal actual; colabora en tareas domésticas sencillas; salida ocasional sin grupos de apoyo

AIVD - Laboral



Mapa de Actividades Críticas

Rehabilitación

Programa hospitalario de 3-4 meses en el INR con equipo multidisciplinario; reingreso desde el 17/07/2026.



Progresión

Uso de andador para marcha segura; molestias de adormecimiento en frío/sedestación prolongada que ceden con el movimiento.



Barreras

- **Geográfica:** Reside en Satipo (Junín), lejos del INR en Lima.
- **Económica/Social:** No genera ingresos propios (depende de sus hijos) y su cuidadora principal tiene 70 años.
- **Afectiva:** Separación de su pareja tras el evento; hijos residen en Lima.



Facilitadores

- **Institucionales:** Atendido en el INR (centro de referencia nacional).
- **Entorno/Transporte:** Vivienda de un solo piso sin barreras percibidas; se traslada de forma independiente en auto/taxi.
- **Clínicos:** Clasificación AIS "D" favorece el pronóstico de marcha



Puntos de Dolor

- Adormecimiento (parestesias) en brazo derecho y miembros inferiores.
- Exacerbación del malestar ante el frío y la sedestación prolongada.
- La marcha representa la actividad con mayor dificultad funcional.
- Distanciamiento familiar y afectivo tras la lesión.

Expectativas

Lograr una marcha más autónoma y segura como meta central del tratamiento





Muchas Gracias

